

Листок расписания и график приёма Габапентина

Пациент: Рамзес, Кане-Корсо, 11 лет | **Диагноз:** ХБП 2 стадии по IRIS + Хилёзный
плевральный выпот (подозрение на лимфому)

Препарат: Габапентин (Gabapentin)	Форма: Капсулы / Таблетки	Выведение: Почечный клиренс
Почечный статус: ХБП Stage 2	Креатинин: 132–140 мкмоль/л	Особенность: Увеличен T _{1/2} (10–20х)

Клиническое обоснование жесткого графика:

При хронической болезни почек (ХБП 2 стадии) период полувыведения габапентина существенно удлинится из-за снижения клубочковой фильтрации. Препарат **не является нефротоксичным**, но может накапливаться (кумулироваться) в крови при нерегулярных интервалах. **Главное правило:** принимать strictly по часам с равными интервалами (каждые 12 часов при 2-кратном режиме) во избежание прорывов костно-нейропатической боли или, наоборот, глубокой седации и шаткости походки (атаксии).

Варианты суточного графика приёма (согласовать с врачом)

Режим приёма	Интервал	Точное время приёма	Примечания и приём с едой
Основной (2 раза в день) Рекомендуемый базовый	Каждые 12 часов	08:00 — Утро 20:00 — Вечер	Давать во время или сразу после кормления (с небольшим лакомством). Минимизирует дневную седацию.
Сдвинутый (2 раза в день) При вечернем графике	Каждые 12 часов	10:00 — Утро 22:00 — Ночь	Подходит, если владелец поздно возвращается с работы. Важен строгий разрыв в 12 часов.
Дробный (3 раза в день) При сниженной дозе	Каждые 8 часов	07:00 — Утро 15:00 — День 23:00 — Ночь	Применяется, если назначен меньший разовый объём для более мягкого и ровного обезболивания.

Правила безопасности и контроль побочных эффектов

- Категорически запрещена резкая отмена:** Внезапное прекращение приёма габапентина вызывает «синдром рикошета» — резкое усиление боли, дискомфорта и тревожности.
- Контроль кумуляции (атаксия и седация):** Если после дачи препарата у Рамзеса наблюдается явная вялость, заплетание задних лап или шаткость походки — свяжитесь с врачом для плавной редукции разовой дозы.
- Сочетание с Преднизолоном и ХТ:** Габапентин полностью совместим с глюкокортикоидами и цитостатиками протокола СНОР, но требует поддержания стабильного гидратационного статуса.
- Приём с едой:** Давать капсулу с небольшой порцией влажного нежирного корма (без превышения жирности рациона при хилотораксе).

Ежедневный журнал учёта приёма Габапентина и симптомов

Отмечайте точное время дачи препарата и уровень седации/шаткости походки для коррекции дозы врачом.

Дата	План (Время)	Факт (Время)	Доза (мг)	Седация / Атаксия (1-5)*	Обезболивани е (1-5)**	Заметки владельца
День 1 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 2 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 3 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 4 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 5 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 6 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 7 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 8 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 9 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 10 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 11 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 12 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 13 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					
День 14 (__.__) Утро	08:00					
Вечер	20:00					

***Шкала седации/атаксии (1-5):** 1 — бодр, координация отличная; 3 — умеренная вялость, легкое покачивание задних лап; 5 — глубокий сон, сильная атаксия (связаться с врачом!).

****Шкала обезболивания (1-5):** 5 — встаёт легко, боли нет; 1 — выраженная скованность, стоны, боль при движении.

Контакты лечащего врача: _____ тел: _____